ไม่ได้วัด เพราะกดวัดในคอมระบบไม่เป็น อาจารย์ก็บอกว่ากดไม่เป็นเหมือนกัน มันเป็น film CD
ถามว่า เท่าไหร่ drain ดันจำผิด ตอบไป 5 ที่จริงคือ 7
อาจารย์เลยถามว่า คิดถึงเชื้ออะไร ตอบ DDx ได้ แต่ ตอบ CT finding ที่จำเพาะต่อเชื้อไม่ได้
ย้อนถามว่า ถ้า drain ลักษณะหนอง แยกเชื้อยังไง ก็ตอบไม่ได้
ถาม ATB ให้ ceftazidime metro
อาจารย์บอกว่าให้ cef3 metro สรุปไม่ใช่ melioid
C/S G/S negative

ให้แนะนำ คนไข้ ตอนนี้รวนแล้วเพราะมาผิดทางเยอะ แนะนำไม่ค่อยได้มาก
ก็แจ้งว่าเป็นอะไร รักษาอะไร คุมเบาหวานไป อาหารที่ต้องคมเบาหวาน

ท้ายสุดอาจารย์ถามว่าให้ ATB กี่ week ตอบ8 อาจารย์บอกผิด 6week
สรุปข้อนี้เสียเวลามาก ตรงตรวจร่างกายผิด พามั่ว อาจารย์ พยายามดึงมา liver abscess
แต่ตรวจร่างกายมันไม่ไปด้วย เลยไปไม่ถึงตอนแรก กว่าจะกลับลำก็ CXR แล้วเหลือเวลาก็ไม่มาก และรวนมาตอบผิดอีกเยอะเลย

วชิระพยาบาล

ตุ้ย

Short case

- Loop1 ,2 เหมือนกัน
    - o Cerebellar ataxia
    - o MR
    - o Advice แจ้งข่าวร้าย AML

Long case เช้า

1.) SLE with LN with AIHA
2.) ALS
3.) CBD stone with HIV
4.) ET with c CVST
5.) TS with ckd
6.) COPD with PHT

Long case บ่าย

1.) CA nasopharynx

2.) Digorge syndrome มาด้วย hypoCa

3.) Empty sella syndrome

4.) CVST มาด้วยชัก

5.) Abdominal tb lymphadenitis

6.) Portopulmonary hypertension

Long case 1

Case 60 year ผู้ชาย เจ้าหน้าที่การแพทย์ กทม. ข้าราชการ คนไข้ดูดีมาก เหมือนไม่ป่วยเลย

CC ; ปวดท้อง 5 ชม. PTA

PI ; 5 ชม. PTA มีอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ เป็นหลังกินข้าว เป็นแน่นท้องดันขึ้น ปวดตลอดเวลา ไม่มีปวดเป็นพักๆ ไม่ร้าวไปไหน ไม่มีคลื่นไส้หรืออาเจียน ไม่มีเหลือง ไม่มีไข้ อาการไม่ดีขึ้น จึงมารพ. (คนไข้ admit 5 วันแล้ว)

3 m. PTA เคยมีอาการมาก่อน ลักษณะคล้ายๆกัน มานอนรพ. 3 วันได้ยาฉีด อาการดีขึ้น

PH ; U/D HIV infection on ARV ; Atazanavir, lamivudine, abacavir กินมา 10 ปี last cd4 400 (คนไข้กะเอา), ไม่เคยมีOI

FH , SH ปกติดี, ROS > urine ออกดี ไม่เคยส่องกล้อง

PE ; A thai man, look good

V/S ; WNL

HEENT ; pink , no jx, no OT or OHL

Heart ; WNL

Lung ; clear

Abdomen ; liver 1 cm BLRCM, spelnic dullness negative, shifting dullness negative

Ext ; no edema , no ppe

Imp , 1.)Acute epigastric pain

2.)U/D HIV

DISCUSSION

Acute epigastric pain ; คิดถึง Hepatobiliary system มากสุด

เพราะ ปวดเหมือน biliary colic ddx

1.) Gallstone with biliary colic >> ddx from cholesterol, pigmnted or Atazanavir stone อาจต่องระวังว่ามี acute cholecystitis หากปวดไม่หาย เริ่มมีไข้

2.) Cbd stone คิดถึงน้อยกว่าเพราะไม่เหลือง

3.) Aids cholangiopathy>> บอกว่าโอกาสเป็นน้อย เพราะไม่มีsign of low HIV,มักจะเหลืองด้วย

4.) Other organ eg. Stomach , pancreas แต่ไม่มี feature ที่สงสัย

HIV >> cd4 ดี ไม่มี sign of low immune

Investigation

Cbc : no leukocytosis

Bun/ Cr>> Cr 1.9 >> อาจมี ckd เดิม

U/S upper abdomen ; ให้อ่านเอง มี gallstone , no thickening gallbladder, no pericholecystic fluid, cbd not dilate, Small size both kidneys

CT abdomen ; cbd dilate with cbd stone

Dx ;

CBD stone ddx from atazanavir

Hlv

Mx : ERCP

ATB if sign of cholangitis

Then cholecystecotmy

Switch ยาเป็นกลุ่มอื่น เพราะอาจเป็นจาก atazanavir

Tx ; ckd

Long case 2

Case 53 ปีผู้ชาย , ค้าขาย กทม , บัตรทอง แว๊ปแรกเห็นคนไข้มี proptosis 2 ตา คิดในใจ Graveป่าวน้อ

CC ; ปวดหัว 3 เดือน

PI ; 3 m ปวดหัวขมับและรอบกระบอกตาซ้าย ร่วมกับมีชาหน้าซ้าย (คนไข้ชี้ชัดเจน V1-2) , มองเห็นภาพซ้อนในแนวราบต่อมาในแนวตั้ง ไม่มี photophobia มีคัดจมูกซ้าย ไม่มีเลือดกำเดา มีหูอื้อซ้าย ไม่มีคลำได้ก้อน ไม่ได้ไปรักษาที่ไหน น้ำหนักลด10 kg ไม่เบื่ออาหาร

PH ; no u/d

ROS ; no clinical sign of hyperthyroid, no AI, no hypogonad, no polyuria

PE ; เอาที่ positive เลยละกัน

Weber , rinne >> air conductionloss left

Otoscopy ; loss of cone of light left, no redness

Facial tenderness left maxillary sinus

Thyroid not enlarge

No CLN,SCLN

Neuro ; CN 3,4,V1,V2,6 left palsy

Pulpil normal size , react to light both sides

VA ; good both side

Opthalmoscopy ; normal disc

Discussion

1.) Chronic progrssive headache with cavernous sinus syndrome

Ddx ; CA nasopharynx>> hearing loss left, nasal congest left

2.) Lymphoma eg. NK t cell อยู่ตำแหน่งบริเวณ nasal sinus ได้

3.) Infecfion eg. Mucormycosis, Aspergillosis

4.) Idiopathic eg, Tolosa hunt syndrome

Investigation

Consult ent ; nasal endoscopy ; mass at left nasophalynx

Bx ; non keratinizing squamous cell carcinoma

CT paranasal sinus (อ่านเอง) Mass at left nasopharynx obliterate Russenmuller fossa with intracranial extension involve left sphenoid bone and temporal lobe and also involve left cavernous sinus with thrombosis

Lymph node ดูเองเห็นไม่ขัดเลยแจ้ง อ. ไปว่าขอ official reportเรื่อง lymph node ครับ เพราะเปลี่ยน staging > อ.บอกเห็นด้วย ดูไม่ออกเหมือนกัน 555 >> subcentrimetric lymph node involvement both sides

CXR ; no mass

Staging ; T4N1M0 >> stage IV

Tx ; CCRT and pain control headache

Advice

Case นี้จบก่อนเวลา 15 นาที 555, โชคดีอ่านก่อนไปสอบพอดี

โดยรวม วชิระ อาจารย์ใจดีมากกก เอาใจช่วยตลอด เห็นบอกว่าไม่เคยมีใครตกที่สนามนี้ ค่อยๆไปทีละ step จะไปถึง dx แน่ๆ สู้ๆ ทุกคนน

พี่จิ๊บ

เคสเช้า

Case pt ชาย. อายุประมาณ 50 ปี

อาชีพ รับรถแท๊กซี่

CC: ไอแล้วเหมือนจะวูบ 2 เดือนก่อนมา รพ

PI : 2 เดือน. มีอาการไอแล้วจะรู้สึกวูบ แต่ไม่หมดสติ. นั่งพักแล้วดีขึ้น. ไม่มีเจ็บแน่นหน้าอก. มีอาการเหนื่อยง่าย หอบบางครั้ง. ไม่มีไข้. ไม่มีนน ลด. นอนราบได้.อาการวูบจะสัมพันธ์กับอาการไอ เคยมีขาบวมปลายปีที่แล้ว. แต่บวมสองข้างเท่ากัน. มีท้องโต. หมอบอกตับอักเสบ. รักษาไม่ได้อัลตร้าซาว FC 2>3

1 วันไอมากแล้วรู้สึกวูบ. หน้ากระแทกพื้นจึงมา รพ

PH เคยเป็นหืดหอบ. ใช้ยาพ่นไม่ได้เอามาด้วย. พ่นตลอด. ไม่เคยมีหอบต้องเข้ารพ. ไม่เคยใส่ท่อ แต่ปัจจุบันไอบ่อย. ไอมีเสมหะบางครั้ง

ปลายปีที่แล้วมี. ขาบวม. ท้องบวม. ไปรักษาคลินิคบอกตับอักเสบ. ได้ยาขับปัสสาวะมากิน. FC drop. มาตลอด. ปัจจุบันขาไม่บาทเลย

เคสเป็นวัณโรคหลายสิบปี. กินยา 6เดือน

เคยประสบอุบัติเหตุแล้วมีปอดแตก.

Social: ดื่มสุรา. สูบบุหรี่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่. 1ซองนาน 10 ปี

FH : ปฏิเสธโรคหัวใจในครอบครัว. Sudden death

PE BT ไม่วัด. จะแอบค้อนด้วย. RR 16 HR 80 regular BP 120/80

ตอนแรกจากประวัติคิดถึง heart มากที่สุด. กะ lung เน้นตรวจพวกนี้ล่ะ. จะได้ง่ายและถ้าตรวจร่างกายเข้าได้มีเวลาจะได้ซักเพิ่ม. Confirm

A Thai man goog conscious ,no sign liver (ตอนแรกบอกตับอักเสบพยายามหาใหญ่เลย. ถอดเสื้อดู spider naviอันเลยที่เดียว. ไม่เจอจ้า) sat ด้วยนะ 92 RA

HEENT no pale no jaundice

LUNG : AP diameter ก็ดี, clear

HEARt : JVP 5 cm ,PMI at 6 ICS no heaving no thrill ฟังนานมากเลยเพราะต้องหา obstructive lesion ไม่รู้ มโนมั้ยได้SEM LPSB no radiation. ทำ maneuvers ด้วยนะ. แต่รู้สึกว่ามันปกติ. คือตรวจ heart นานมาก

AbD: ปกติ

ext: no pitting edema

ตอนนั้นยอมรับตรวจร่างกายไม่มั่นใจ. แต่ประวัติมันค่อนข้างชัดคือ obstructive lesion แน่ๆ
และ approach near syncope
>>>คิดถึง เลยแยกเป็น structure /arrhythmia /vascular
มากสุด vascular >PHT เป็นได้. แต่ตรวจร่างกายตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ sign เลย. แต่ประวัติเหมือนคนไข้เคยมี RT heart failure มาก่อน. อาจขอตรวจเพิ่มเติม
Structure ที่เป็นได้ทำให้เกิดได้. น่าจะต้อง obstructive lesion. บอก อ เลยว่าคิดว่ามี SEM LLPSB gr2 เบามากๆๆ เลยไม่แน่ใจ HOCM แต่ติดไว้แต่น้อย
Arrhythmia ตรวจร่างกายไม่ได้. ประวัติใจสั่น chest pain ไม่มีแต่ไม่ R/O. EKG หรือคิดถึงมากอาจ holter
ขอ echo ดู RVSP EKG ดู Rt side load CXR ดู pulmonary trunk.อ ให้เท่านี้ก่อน
Echo สรุป RVSP 72 mmhg มี moderate TR >>>PHT แต่film CXR pulmonary trunk ไม่ชัดนะ. และ film เหมือน COPD
เลยขอ R/O class 3 ทำ PFT แต่ยังไม่ทำ. เลยขอ ABG สรุป severe hypoxicemia with chronic respiratory acidosis
CT chest: มาตายตอนนี้ล่ะ. เพราะlung เป็น chronic lung มี bullous เต็มไปหมด. สรุป lung parenchyma แย่มากๆๆๆตอนนี้นั้นคือคิดว่านี้อาจเป็นcause แต่ไม่รู้จาก อาราย pulmonary trunk โตจริง
สรุป PHT due to COPD gold D (Hx. Cor pulmonale)
Advice treatment ตามโพย. PHT. และต้องรักษา COPD ตาม GoLd ด้วยนะ. หยุดบุหรี่สำคัญมาก เคสนี้เหมือน long term o2ด้วยอ่ะ. อ ถามยาใน GoLD Dด้วย

อ บอกดีมาตลอดมาตายตอนจบเพราะCT เยินมากเกิน COPD เลยไม่กล้าบอกว่า COPD เฉยๆ. แต่ อ ว่า CT คนไข้มี TB มาก่อนด้วยเลยไม่ atypical

□□□□✌□✌□✌□✌□✌□✌□

เคสบ่าย
ชายไทย. อายุ 60 ปี
อาชีพ เทศกิจ กทม
CC ปวดแน่นท้อง 1วันก่อนมา รพ
PI : 1 เดือน ปวดท้องแน่นๆ. อิ่มง่าย. ไม่มีท้องโต. มีไข้ต่ำตอนเย็นเป็นตลอด. นนลด 20 กก. อาการแน่นตรงกลางบอกตำแหน่งไม่ได้. มีร้าวไปหลังบางครั้ง. ไม่ได้ไปรักษาที่ไหน. ไม่มีตาเหลือง. ตัวเหลือง ไม่มีท้องเสีย. ไม่ถ่ายเป็นมัน

1วัน. กินเหล้า. ไม่ได้กินข้าว. เข้านอนปวดแน่นท้องมาก. . ไม่อาเจียน. ถ่ายผายลมได้จึงมา รพ

PH : กินเหล้าตลอด. ไม่เคยตรวจสุขภาพ. แต่ยังไม่มีเบาหวาน

มีสักลาย

ไม่มีไอเป็นเลือด. ไม่มีไอเรื้อรัง no contect TB

FH : ปกติ

อันนี้เหมือนกัน. คิดถึง GI. ก็ตรวจท้องหนักๆซิค่ะ

PE good conscious,no sign chronic liver

HEENT : moderate pale ,no jaundice

Lung: clear

Heart :normal

Abdomen : soft liver 7 cm lt lobe no enlarged splenic dullness negative

Shifting dullness positive ,no abnormal massค

PR อ ว่าปกติ

Ext :no pitting edema

คนนี้คือ มาด้วย GI symptoms บอกตรงๆตรงได้แต่ ascites ไม่รู้จริงหรือป่าวเพราะมันน้อยมากๆๆๆ. คือเคาะหาlevelนานมาก. แต่คือว่ามันคือทางเดียวที่จะ approach. ก็คิดว่ามีก็บอก อ ว่าตรวจได้แต่คิดว่าน้อยมาก

อาการแน่นคิดว่ามี Ascites cause peritoneal dz เพราะว่าไม่มี sign chronic liver เลย.

TB peritoneal , CA metastasis risk CA lung (smoking)แต่มักไม่มาที่นี้. หรือ primary เองคือ mesothelioma (rare) ca colon มักมาแต่คนนี้ไม่มี bowel habit change เลย

ส่วนถ้าตรวจผิด. อาจเป็นธรรมดาที่รักษาหายแล้ว. จึงตรวจร่างกายได้ปกติ(ตอนนั้นไม่แน่ใจ ascitis) คือ acute pancreatitis แต่ acute pancreatitis ไม่อธิบายไข้. นน. ลด. ยกเว้นเป็น CA pancreatic หรือ Lymphoma ที่ตรวจ LN ไม่ได้

มโนไปต่างๆ

สรุป ขอ film AAS ,U/S ดูน้ำว่ามีจริงมั้ย. ถ้ามีก็ tap ,CBC เพราะซีด ,LFT ,amylase

สรุป film ดู bowel มาตรงกลาง น่าจะมี ascites □□□□□, มี calcified pancreas ด้วยนะ 555ตรงลงปวดนี้หรือป่าวว่ะ. แต่ก็บอกว่าไม่อธิบาย. ไข้. นน ลด

Tap มาเป็น narrow SAAG ,TP สูง. ,Lym predominant

สรุป. ยังคิดถึง TB peritoneal, CA something อยู่

Amylase ไม่ขึ้นนะ จำตัวเลขไม่ได้แต่ก็บอก อ ว่าไม่ขึ้นไม่ R/O อ ก็อ่อออไปด้วยนะ 555

CT whole abdomen : มี cystic mass with septateติดทั้งpancreas และกระจาย.

ตอนนั้นบอกเลยไม่รู้อะไร. แต่ไม่เหมือน LN เพราะ cystic
เลยบอกจะ consult IR เจาะตรวจ. สรุปบอกว่ามีlesion ใกล้ stomach เลย scope เอา
เลยขอย้อม AFB positive จ้า. สวยมากๆๆๆๆ
สรุป. Intraabdominal TB LN with chronic pancreas
ข้อเสียคือ ไม่เคยเห็น image TB LN เลยไม่รู้ว่ามันเป็น cystic lesion
Advice ยา. ตัวโรคแล้วก็เลิกเหล้าด้วยนะ.
เวลาเหลือนิดหน่อย. อ เลยถามกลับไปทำงานที่ไหน. จะต่ออาราย. (อยากบอกว่าหนูจะไปแต่งงาน
ค่ะ 5555555)พอกันที่หมดเวลา medicineeee. เมื่อกริ๊งดังขึ้น

รพ ธรรมศาสตร์

พี่ปุ้ย

สนามสอบรพ ธรรมศาสตร์ เป็นสนามสอบขนาดใหญ่มีผู้ร่วมสอบทั้งหมด 12 คน การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิจะไกลค่อนข้างมาก เพราะ รพ อยู่ฝั่งปทุมธานี ที่พักพี่พักที่ deluxx ธรรมศาสตร์ข้อดีคือปลอดภัย อยู่ในมหาวิทยาลัย ข้อเสียคือไกล ไม่มีที่กิน มีแต่ 7-11ใต้ที่พัก การเดินทางไปรพ ต้องลุ้น taxi ถ้าให้ย้อนเวลาอาจไปพักที่อื่น แต่ก้อไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนดี 555
บรรยากาศการสอบ นัดสอบ 8.00 ไปถึงที่สอบ 7.30 มีขนมปังให้กินน้ำเปล่ามีให้ แต่ช่วงเวลานั้นกินไม่ลง จะมีรายชื่อติดไว้ให้ว่าใครสอบช่วงเช้า ใครสอบช่วงบ่าย แต่ของน้องเปลี่ยนระบบ ก้อไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกัน ข้อแนะนำเพิ่มเติม คืนก่อนสอบจะเครียดมาก นอนไม่หลับ ใครมีปัญหาควรพกยาไปด้วย หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟจ้า สำคัญคือสติๆ คือพี่นอนไม่หลับเบย ตอนสอบเลยเป็นเบลอๆหน่อยๆ
สอบรอบเช้า

Long case เช้า

1. cavernous sinus syndrome
2. hashimoto thyroiditis c HOCM
3. dermatomyositis c cancer
4. lupus nephritis

Long case บ่าย

1. LHRH คล้ายๆ kallmann เห็นเขาบอกมาอีกที 55
2. PBC มาด้วยเหนื่อย
3. infected bronchiectasis
4. amyloidosis